



Collection MedWIZ

1^{re} année médecine

SANTÉ, SOCIÉTÉ ET HUMANITÉ

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Influence de la culture sur la santé	6				
02	Du normal au pathologique en médecine clinique	8				
03	Relation soignant-soigné	10				
04	Décision médicale et relation médecin-patient	12				
05	Bioéthique	14				
06	Éthique médicale	16				
07	Déontologie médicale	18				
08	Droit médical	20				
09	Déterminants de la santé et leurs effets sur la santé de la population	22				
10	Étude des différents indicateurs de la santé	24				
11	Notions de besoin, demande et offre de soins	26				
12	Organisation sanitaire en Algérie	28				

INFLUENCE DE LA CULTURE SUR LA SANTÉ

I. LA CULTURE : DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES

- Définition : Ensemble d'idées, de coutumes et de comportements partagés par une société, en constante évolution.
- Caractéristiques :
 - Dynamique, évolutive, transmise entre générations
 - Partagée par un groupe
 - Symboliquement identifiée (langue, vêtements, musique)
 - Intégrée à tous les aspects de la vie
- Facteurs influençant une culture :
ethnie, langue, religion, sexe, classe socioéconomique, âge, orientation sexuelle, origine géographique, histoire, instruction, éducation, expérience de vie
- Modèle de l'iceberg :
Les éléments culturels explicites (visibles) ont souvent moins d'influence que les éléments invisibles/inconscients.

II. CONTINUUM CULTUREL : COLLECTIVISME VS INDIVIDUALISME

CULTURE COLLECTIVISTE	CULTURE INDIVIDUALISTE
Axée sur le "nous"	Axée sur le "je"
Favorise interdépendance	Valorise l'autonomie
Liens familiaux étroits	Choix individuels justifiés
Valorise respect et obéissance	Valorise initiative et réalisations
Objectifs collectifs, coopération	Moins d'importance aux valeurs collectives

- Impact sur les soins : Inclure la famille élargie dans les discussions sur diagnostic/traitement. Obtenir le consentement familial pour certaines interventions.
- Exemple clinique : Une mère collectiviste ne prend pas seule une décision médicale pour son enfant ; elle doit consulter son mari et sa belle-mère avant d'autoriser des examens.

III. EFFETS DE LA CULTURE SUR LA SANTÉ

- La culture influence :
 - La perception de la santé et de la maladie
 - Les croyances sur les causes (microbes, fatalisme, djinn, mauvais œil)
 - Les maladies honteuses et leur stigmatisation
 - Les activités de promotion de la santé privilégiées
 - Les lieux et moments de consultation
 - Les interactions avec les professionnels (contact visuel, communication)
 - L'acceptation du diagnostic et des traitements
 - Les perceptions de la mort et de la fin de vie
 - La dynamique familiale et les rôles de genre

IV. CONSEILS AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ

- Examiner ses propres biais culturels
- Respecter les diverses perceptions des traitements
- Utiliser des interprètes si nécessaire
- Écouter attentivement et confirmer la compréhension
- Comprendre la perception du patient sur sa santé
- Accepter les traitements complémentaires tout en informant des risques
- Évaluer l'adaptation culturelle du patient et son soutien social
- Négocier un plan thérapeutique mutuellement compris
- Adapter les supports d'information (verbal/visuel si nécessaire)

V. LA SANTÉ : DÉFINITIONS

- Étymologie :
Du vieil anglais Hoelth (« être en sécurité » ou « globalité du corps »)
- OMS (1946) :
« État de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement absence de maladie »
- Charte d'Ottawa (1986) :
La santé est « une ressource de la vie quotidienne permettant de réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins »
- Conditions nécessaires :
Logement, éducation, alimentation, revenu, écosystème stable, justice sociale, traitement équitable
- Droit à la santé :
Article 25 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme

VI. INFLUENCE SOCIOCULTURELLE SUR LE CORPS ET LA DOULEUR

A. Corps biologique

- Les représentations du corps sont des constructions socioculturelles
- L'anthropologie biologique étudie la variabilité morphologique selon les cultures
- Les comportements (alimentation, activité physique) influencent la morphologie
- Les normes corporelles varient selon les périodes historiques et les cultures
- L'obésité est perçue différemment selon les sociétés (force/réserves vs pathologie)

B. Douleur

- La culture joue un rôle crucial dans l'expérience individuelle de la douleur
- La société fournit un cadre social à l'expression de la douleur (normes, rites)
- La signification de la douleur varie selon les groupes culturels :
 - Épreuve pour acquérir maturité
 - Rituel de passage imposé
 - Occasion de prouver résistance et volonté

C. Représentation du corps (PANKOW)

Quatre composantes essentielles :

1. Forme : limites et unité du corps dans l'espace
2. Contenu : sentiment d'unicité et de familiarité
3. Savoir : connaissance du fonctionnement corporel
4. Valeur : regard culturel et jugement social

VII. DÉTERMINANTS DE SANTÉ

A. Division 1

Endogènes	Patrimoine génétique, maladies transmissibles, dépistages
Environnementaux	Qualité de l'air/eau/sol, logement, perturbateurs endocriniens, climat

B. Division 2

Sociaux	Développement petite enfance, niveau d'instruction, emploi, précarité, environnements sociaux, réseau de soutien
Comportementaux	Tabagisme, alcool, drogues, alimentation, activité physique, sédentarité

DU NORMAL AU PATHOLOGIQUE EN MÉDECINE CLINIQUE

I. INTRODUCTION

- La clinique (du grec klinikê) désigne la médecine pratiquée "au lit du malade"
- Le clinicien soigne le malade, pas la maladie
- La notion de "clinique" s'est étendue à la psychologie et à la formation

II. LA NORMALITÉ : DÉFINITIONS ET APPROCHES

1. Approche statistique (Quetelet, XIXe)

- Normal = ce qui est partagé par la majorité (courbe de Gauss)
- Limite : où fixer le seuil entre normal et anormal ?
- Être "extrême" n'est pas forcément négatif (ex : QI élevé)

2. Approche sociale (Zarifian)

- La normalité définie par consensus social → variable selon l'époque et la culture
- Limite : les "faux-self" (Winnicott) → personnes "trop bien adaptées" masquant un déséquilibre profond
- Danger : la normalité devient un idéal collectif imposé par la force

3. Approche "absence de pathologie" (Buss)

Critères de la pathologie :

Critère	Définition
Inconfort	Souffrance ressentie par la personne
Bizarrie	Déviations perçues par l'entourage
Inefficacité	Handicap psychique (incapacité)

- Limite : une personne peut être malade sans se sentir inconfortable, et inversement

4. Évolution récente (Foucault)

- Avant : il fallait se sentir malade pour être malade
- Aujourd'hui : on peut être diagnostiqué malade sur des mesures objectives (ex : hypertension sans symptômes)
- Basculement : la médecine s'intéresse plus à la normalité qu'à la santé (biopouvoir)

III. REPRÉSENTATIONS SOCIALES (RS) DE LA SANTÉ ET DE LA MALADIE

A. Théorie des RS (Moscovici, Jodelet)

- Toute réalité est représentée, appropriée, reconstruite par l'individu ou le groupe
- Fonctions : savoir, identitaire, d'orientation, justificatrice

B. Niveaux explicatifs (Doise) :

1	Intra-individuel	Gestion de la maladie et remaniement identitaire
2	Inter-individuel	Relation patient-médecin, entourage
3	Positionnel	Relation avec l'institution de santé (savoir savant)
4	Idéologique/culturel	Croyances sociales, regard social sur la maladie (ex : sida ≠ diabète)

C. Représentation de la santé (Herzlich) :

1. "Santé vide" = absence de maladie
2. "Fond de santé" = capital de robustesse biologique
3. "Équilibre" = bien-être psychophysique et efficience

D. Représentation de la maladie :

1. "Maladie-destructrice" → déni, refus de soins
2. "Maladie-libératrice" → repos, libération (surtout chez les non-malades)
3. "Maladie-métier" → lutte active, coopération avec le médecin

IV. VULNÉRABILITÉ

- Du latin vulnus (blessure) → potentialité à être blessé
- Concept transdisciplinaire depuis les années 1990
- En santé : désigne les inégalités sociales devant la maladie
- Définition : exposition au risque + capacité à s'y adapter (avant) + capacité à assumer les conséquences (après)

V. STIGMATISATION (Goffman)

- Stigmate = attribut qui discrédite une personne et la rend "différente"
- 3 catégories :

1	Stigmates corporels	Handicap, défiguration
2	Stigmates de personnalité / passé	Maladie mentale, toxicomanie, prison
3	Stigmates tribaux	Ethnie, religion, nationalité

- Le normal et le stigmatisé ne sont pas des personnes, mais des points de vue socialement produits
- Désstigmatisation / démythification = actions visant à défaire les préjugés

RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ

I. DÉFINITIONS ESSENTIELLES

- Relation : Lien dynamique et évolutif entre deux personnes, influencé par les contextes, les affects et les échanges passés.
- Soignant : Personne délivrant des soins préventifs, curatifs ou palliatifs (médecins, paramédicaux, pharmaciens, auxiliaires).
- Soigné : Personne bénéficiant de soins (patient, bénéficiaire, sujet, acteur).
- Relation soignant-soigné : Lien bilatéral asymétrique où le soignant possède les connaissances et le patient est en situation de besoin.

II. CARACTÉRISTIQUES DE LA RELATION

- Asymétrique : soignant = actif/sachant ; patient = passif/demandeur
- Rôles irréversibles : statuts non interchangeables
- Intimiste : intrusion dans la sphère privée du patient
- Basée sur la confiance : conditionnée par les compétences et l'attitude du soignant

III. LES 4 NIVEAUX DE RELATION (Malabœuf)

NIVEAU	DESCRIPTION
1. Civilité	Salutations, politesse, codes sociaux
2. Fonctionnelle	Recueil d'informations cliniques et sociales
3. Compréhension	Écoute active, empathie, soutien
4. Aide thérapeutique	Relation de confiance, mobilisation des ressources du patient

IV. LA COMMUNICATION

A. Trois modes

- Verbal : langage écrit/parlé
- Paraverbal : intonation, rythme, débit
- Non-verbal : posture, gestes, regard, expressions

B. Caractère circulaire

Émetteur ↔ Récepteur avec rétroaction (Wiener)

V. SPÉCIFICITÉS SELON LE CONTEXTE

A. Maladie chronique

- Adhésion et observance au long cours
- Intégration du traitement dans la vie quotidienne
- Temporalité divergente soignant / patient

B. Maladie grave

- Lieu calme et confidentiel
- Écoute active, questions ouvertes
- Empathie manifeste
- Information orale + documents écrits si disponibles

VI. ÉLÉMENTS CLÉS DE LA RELATION DE CONFIANCE

A. Pacte de soins (Ricœur)

- Présence, confiance, conscience, alliance contre la maladie

B. Empathie

- Attitude fondamentale
- Prise de risque
- Interprétation mesurée

C. Attitudes nécessaires

- Écoute
- Non-jugement
- Disponibilité
- Respect

VII. CONCLUSION

La relation soignant-soigné est évolutive, asymétrique et exige du soignant :

- Des compétences relationnelles
- Une adaptabilité constante
- Une posture éthique et empathique
- Une communication efficace et adaptée

Objectif final : « Prendre soin » pour instaurer un climat de confiance et faciliter la guérison.